جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : شفيقه السيد سعد الحطيم
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** البساتين **العنوان :** 11ش العمده
رقم البطاقة : 25005202100747 **رقم التليفون :** 01125674642 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 20-05-1950 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: شفيقه السيد سعد الحطم
National ID: 25005202100747

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bone scintigraphy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPT

MDT FORM

Patient Name	شفيقة السيد سعد	Age	74
Sex	F	Special habits	
Family History		Comorbidity	DM, HTN
Surgical History		Telephone	01211702706 / 01113510838
Menopausal Status	post	Marital Status	
ID	25005202100747	Medical ID	180/2022
Date	13-10-2025	Reason for MDT	

Medical Report

Affected breast:

Pathology:

ER: 8/8

PR: -ve

HER2: -ve

Ki67: 10%

T N M:

S.M:
PERFORMANCE STATE 2
Metsworkup:
Doctor's notes:
Referred from kasr ainy
Rt upfront BCS+SLNB in 2015: pT2 N0, ER +ve, PR -ve, HER2 -ve, Ki67 10%
Received adj 4 AC, 4 TAXOTERE, PORT, TAM 2016 → 2019 then AI → 2022
9/2021 Bone scan → sternoclavicular junction, bilateral rib, multiple vertebral lesions
Kisqali / Faslodex x15 cycle, started (2/2022 → 4/2023) → shifted to Faslodex / Ibrance till 9/2023
Off treatment since then due to problems with MOH support
CTs → SD of subtle changes (almost -ve)
BS → osseous lesion at medial end of Rt clavicle
Recommendations:

MDT DECISION	For: IN VIEW of having bone only disease with S.D Resume faslodex/ibrance +zometa 1-3 months

Name	د/شيماء لاشين	د/ نرمين رمضان	
Signature	12/10/2025	Nermen Ramadan	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

CAIRO UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE
PATHOLOGY DEPARTMENT

Pathology No: 2127 Age: 63 Sex: female
Name شفيقة السيد سعد Hospital_no:
Clinical diagnosis
Nature of specimen Breast mass, deep margine wider excision
Department: Date: 14/04/2015

PATHOLOGY REPORT

GROSS :
Fibrofatly tissue piece ; 3x3 cm. Totally submitted.

MICROSCOPIC:
Examination of the specimen received revealed fibrofatly tissue pieces .
No malignant cells were seen.

DIAGNOSIS:
EXCISED DEEP MARGIN:FREE DEEP MARGIN.

PROF.DR. AHMED ABDEL AZIZ

21/5/2015
11am

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

وحدة بحوث الأورام
قسم الباثولوجيا - المعهد القومي
للأورام

IMMUNOHISTOPATHOLOGY

Patient Name: [illegible]

Lab.No:2015-318

Date: 5/2015

Sex: Female

Markers: ER, PR, Her 2 neu and Ki67

Procedure:
Sections from paraffin blocks were treated with monoclonal antibodies against ER, PR, Her 2 neu and Ki67 using streptavidin biotin peroxidase system. DAB was used as substrate as well as chromogen. Hemtoxylin was used as counter stain

Results:
Examination of sections treated for ER revealed positive nuclear staining of tumor cells by chromogen.
Examination of sections treated for PR revealed no nuclear staining of tumor cells by chromogen.

Examination of sections treated for Her 2 neu revealed no membranous staining of tumor cells by chromogen

Examination of sections treated for Ki67 revealed positive nuclear staining in about 10 % of tumor cells by chromogen

DIAGNOSIS:

- POSITIVE FOR ER SCORE 8/8
- NEGATIVE FOR PR
- NEGATIVE FOR HER 2 NEU
- KI67:10%

PROF. DR. SAMIA GABAL

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Shafika Al Sayed Saad Alhtim	Date : 25/08/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 75 Year(s)
Medical ID: 180/2022	Pat. ID: 14230

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

- **Known case of breast cancer.**

1. **Chest:**
   - Still noted left breast outer domain and left axillary metallic surgical clips.
   - Right lower lobe (anterior segment) para-fissural solid pulmonary nodule still measures about 7 mm.
   - bilateral basal atelectatic bands.
   - Few mediastinal (prevascular and paratracheal) lymph nodes are seen, not exceeding 1 cm at short-axis diameters likely reactive.
   - No evidence of pleural effusion.
   - Enlarged thyroid gland, with heterogeneous nodular parenchyma and retro-sternal extension of the left lobe.
   - Bilateral elasto-fibroma dorsi are still noted.
2. **Abdomen and pelvis:**
   - Cirrhotic hepatic features with wavy irregular outline and prominent caudate lobe. With still noted few bilobar subtle enhancing focal lesions.
   - Gall bladder 1.6 cm stone. No intra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal CT appearance of the pancreas and both suprarenals.
   - Still noted bulky uterus.
   - Right adnexal metallic prosthesis is noted mostly missed IUD.
   - No abdominal or pelvic lymphadenopathy or collections.
3. **The scanned skeleton shows:**
   - Bilateral ribs abnormal modeling, likely healed old fractures.
   - Dorsal and lumbar small lytic osseous foci are seen.

OPINION:

Status follow up showing rather stationary course (compared to the previous report.

Dr. Asser Ahmed

Dr. Asser Ahmed

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

???, ????? Patient ID: 10110225004412 DOB: 20-May-1950 Date: 10-Mar-2025
tient Lastname: [illegible]
tient Firstname: [illegible]
IS Patient ID: 10110225004412
IS Patient ID: 366901
ate of Birth: 20/05/1950

rocedure: 70030, Bone Scan
Medical Question:
Clinical Comment:

REPORT TEXT

99mTc MDP Dual Phase Bone Scan Report (10/03/2025)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP Revealed:

" Active tracer uptake is seen at manubrium sterni, Another warm tracer uptake at left lower sternal body for CT correlation to define its nature.
" Otherwise, no definite evidence of active osseous deposits seen all over the rest of the surveyed skeleton.
" Degenerative changes over the dorso-lumbar vertebrae.
" Arthritic changes are noted over both shoulder, both knee and right sterno-clavicular joints.
" Both kidneys are visualized.

Conclusion: -
" Equivocal sternal lesion for CT cuts correlation.

Much Obliged
Randa Ali, MSc

REPORT TEXT ENDE

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]